HOOFDMATERIAAL

120 kant-en-klare verslagsjablonen

120 verslagsjablonen voor röntgenfoto, CT, MRI en echo/Doppler. De velden Techniek, Vergelijking, Bevindingen en Conclusie staan klaar; jij vult alleen de vierkante haken in. Doel: een verslag dat je supervisor niet opnieuw hoeft te schrijven.

Inhoud

Hoe gebruik je de sjablonen

Deel 1 · Röntgen (röntgenfoto) — 30 sjablonen

Deel 2 · CT — 35 sjablonen

Deel 3 · MRI — 25 sjablonen

Deel 4 · Echo en doppler — 30 sjablonen

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe gebruik je de sjablonen

Elk sjabloon is de uitgeschreven vorm van de 4-stappenmethode: VOORBEREIDEN · DOORLOPEN · BESCHRIJVEN · SAMENVATTEN.

> *Een sjabloon vervangt het nadenken niet; het zorgt ervoor dat je wat je denkt volledig opschrijft, in de volgorde die je supervisor verwacht.*

SJABLOONVELD	STAP IN DE METHODE	WAT SCHRIJF JE
Techniek	VOORBEREIDEN	Onderzoek, projectie of sequenties, contrast en fase, technische kwaliteit. Is die onvoldoende, schrijf dat dan duidelijk op.
Vergelijking	BESCHRIJVEN · Vergelijk	Datum en modaliteit van het eerdere onderzoek; zo niet: «er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking».
Bevindingen	DOORLOPEN + BESCHRIJVEN	Elke regio elke keer in dezelfde volgorde; de juiste term (densiteit / signaal / echogeniciteit), lokalisatie, grootte, begrenzing. Noteer ook de belangrijke negatieve bevindingen.
Conclusie	SAMENVATTEN	Beantwoord de klinische vraag, de belangrijkste bevinding eerst, zo nodig differentiaaldiagnose en advies. Bij een spoedeisende bevinding: aan wie en hoe laat die is gemeld.

Vierkante haken

In de sjablonen **[rechts/links]**, **[.. mm]**, **[datum]**, **[uur]** zijn patiëntspecifiek. Opties staan gescheiden door een schuine streep: laat de juiste staan, verwijder de rest. Voordat je het verslag ondertekent, mag er geen enkele vierkante haak meer in de tekst staan.

1. **Kies het juiste sjabloon** — op basis van het onderzoek en de hoofdbevinding. Begin bij een normaal onderzoek met het sjabloon «Normaal».
2. **Vul de velden Techniek en Vergelijking in** — noteer de datum van het eerdere onderzoek alleen als je het echt hebt geopend.
3. **Orden de bevindingen volgens je eigen doorloop** — voeg een bevinding toe die niet in het sjabloon staat, verwijder een bevinding die je niet ziet.
4. **Schrijf de conclusie op basis van de klinische vraag** — je kunt de passende zin uit de Bank met 200 conclusiezinnen gebruiken.

5 **Pas de Checklist verslag op één pagina toe** — onderteken daarna of stuur het naar je supervisor.

De copy-pastevalkuil

Fouten in zijde, maat en datum ontstaan meestal door tekst die uit het sjabloon is blijven staan. Controleer elke zin van het sjabloon één voor één aan de hand van het beeld dat je ziet; laat niets staan wat je niet ziet, alleen omdat het «in het sjabloon staat».

De praktijk van je instelling gaat voor

Als het verslagformat, de classificatiesystemen en de termen van je afdeling afwijken van deze sjablonen, volg dan altijd het format van je afdeling. Pas de sjablonen daarop aan.

DEEL 1

Röntgenfoto (conventionele opname)

30 sjablonen: 4 normaal, 26 veelvoorkomende bevindingen tijdens dienst en in de routine.

001 PA-thoraxfoto · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Thoraxfoto's van volwassenen zonder pathologie bij borstpijn, hoesten of preoperatieve beoordeling.

Techniek: Staande PA-thoraxfoto. Inspiratie en penetratie adequaat, geen duidelijke rotatie.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Trachea in de middellijn. Hartgrootte binnen normale grenzen. Mediastinum en hilaire structuren normaal van aspect. Geen consolidatie, massa of nodus in het parenchym van beide longen. Sinus phrenicocostales vrij. Geen pneumothorax. Diafragmakoepels glad begrensd. Geen duidelijke pathologie in de zichtbare botstructuren.

Conclusie: Geen acute cardiopulmonale pathologie op de thoraxfoto.

002 Staande buikoverzichtsfoto · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Röntgenfoto's zonder pathologie als antwoord op de vraag naar obstructie of vrije lucht bij buikpijn.

Techniek: Staande buikoverzichtsfoto; diafragmakoepels in beeld.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen vrije lucht onder het diafragma. Geen gedilateerde darmlissen met lucht-vloeistofspiegels. Gas in colon en rectum. Geen duidelijke radio-opake steen. Psoasschaduwen herkenbaar. Afgebeelde botstructuren normaal.

Conclusie: Geen tekenen van obstructie of vrije lucht op de buikoverzichtsfoto.

003 Röntgenfoto pols · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Röntgenfoto's van de pols zonder fractuur of luxatie na een val of verzwikking.

Techniek: [Rechts/Links] röntgenfoto's van de pols, AP en lateraal.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen acute fractuurlijn in de distale radius, ulna en carpalia. Radiocarpale en intercarpale gewrichtsspleten behouden, normale stand. Geen duidelijke wekedelenzwelling.

Conclusie: [Rechts/Links] geen acute ossale pathologie vastgesteld in de pols. Bij klinische verdenking op een scafoïdfractuur kan een occulte fractuur op de röntgenfoto niet worden uitgesloten; klinische follow-up en zo nodig aanvullend onderzoek worden aanbevolen.

004 Röntgenfoto knie · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Casussen zonder botpathologie bij knietrauma of kniepijn.

Techniek: [Rechts/Links] röntgenfoto's van de knie, AP en lateraal.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen fractuur of luxatie. Tibiofemorale en patellofemorale gewrichtsspleten behouden. Suprapatellair geen duidelijke aanwijzingen voor effusie. Botmineralisatie normaal.

Conclusie: [Rechts/Links] geen acute ossale pathologie vastgesteld op de röntgenfoto van de knie.

005 PA-thoraxfoto · Pneumothorax

Wanneer gebruik je het: Casussen waarin je een pleuralijn ziet na borstpijn, dyspneu, trauma of een ingreep. Kan melding vereisen.

Techniek: Staande PA-thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] pneumothorax in de hemithorax zonder zichtbare longvaattekening buiten de pleuralijn; ter hoogte van de apex bedraagt de afstand tussen pleuralijn en thoraxwand [.. mm]. Mediastinale verschuiving [niet gezien/naar de contralaterale zijde]. Ribfractuur [niet gezien/aan rib ...].

Conclusie: [Rechts/Links] pneumothorax. Radiologische aanwijzingen voor spanning [afwezig/aanwezig]. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

006 Thoraxfoto · Tekenen van spanningspneumothorax

Wanneer gebruik je het: Casussen met een grote pneumothorax en mediastinale verschuiving. Spanningspneumothorax is een klinische diagnose; de behandeling kan al zijn gestart zonder op de röntgenfoto te wachten.

Techniek: [PA/Bedside AP] thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] grote pneumothorax in de hemithorax; ipsilaterale long gecollabeerd richting de hilus. Mediastinum en trachea naar de contralaterale zijde verplaatst, ipsilaterale hemidiafragma afgeplat, intercostale ruimten verbreed.

Conclusie: [Rechts/Links] grote pneumothorax en radiologische aanwijzingen voor spanningspneumothorax. Spoedbevinding; aan het klinische team [uur] telefonisch gemeld.

007 PA-thoraxfoto · Pleuravocht

Wanneer gebruik je het: Casussen met afstomping van de sinus phrenicocostalis of een meniscusteken.

Techniek: Staande PA [± lateraal] thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links/Bilateraal] afstomping van de costofrenische sinus en een opaciteit met concave, meniscusvormige bovenrand; [weinig/matig/veel] hoeveelheid pleuravocht. Onderliggende consolidatie in de aangrenzende long is niet te onderscheiden. Mediastinum [normaal/naar de contralaterale zijde verplaatst].

Conclusie: [Rechts/Links/Bilateraal] [weinig/matig/veel] hoeveelheid pleuravocht. Onderliggende parenchymateuze pathologie kan op de röntgenfoto niet worden uitgesloten; correlatie met de kliniek en zo nodig echografie wordt aanbevolen.

008 PA-thoraxfoto · Lobaire consolidatie

Wanneer gebruik je het: Casussen met koorts, hoesten en een opaciteit met luchtbronchogram.

Techniek: Staande PA [± lateraal] thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [boven/midden/onder] kwab: homogeen consolidatiegebied met luchtbronchogrammen. Het kwabvolume is behouden.
[Geen begeleidend pleuravocht/geringe hoeveelheid pleuravocht].

Conclusie: [Rechts/Links] [kwab] consolidatie; kan in samenhang met de kliniek passen bij pneumonie. Radiologische controle na behandeling wordt aanbevolen volgens klinisch oordeel.

009 PA-thoraxfoto · Atelectase

Wanneer gebruik je het: Casussen met een opaciteit en tekenen van volumeverlies.

Techniek: Staande PA [± lateraal] thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [kwab]: opaciteit met volumeverlies; in de fissuur [verplaatsing], in de ipsilaterale hilus [naar boven/naar beneden] retractie en hoogstand van het hemidiafragma.

Conclusie: [Rechts/Links] [kwab] bevindingen passend bij atelectase. Klinische correlatie en zo nodig een thorax-CT worden aanbevolen in verband met een centrale obstructieve oorzaak.

010 Thoraxfoto · Cardiomegalie

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij de hartschaduw op de PA-foto vergroot lijkt. Op een AP-foto kan de hartgrootte misleidend zijn; vermeld dit in het verslag.

Techniek: [PA/AP] thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Cor-thoraxratio vergroot. Longvaattekening [normaal/geprononceerd]. Pleuravocht [niet gezien/...].

Conclusie: Cardiomegalie [Op de PA-foto]. Onderscheid met pericardeffusie is op de röntgenfoto niet mogelijk; bij klinische indicatie correlatie met echocardiografie aanbevolen.

011 Thoraxfoto · Longoedeem

Wanneer gebruik je het: Casussen met dyspneu, hartfalen of verdenking op overvulling.

Techniek: [PA/Bedside AP] thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Bilaterale perihilaire vlindervormige opaciteiten; toegenomen interstitiële tekening (Kerley B-lijnen), peribronchiale verdikking en redistributie naar de bovenvelden. Bilateraal [geringe hoeveelheid] pleuravocht. Hartgrootte [verhoogd/normaal].

Conclusie: Bevindingen passend bij longoedeem; kan passen bij cardiaal oedeem. Klinische correlatie aanbevolen.

012 PA-thoraxfoto · Longmassa

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je een ronde, goed te begrenzen opaciteit ziet.

Techniek: Staande PA- en laterale thoraxfoto's.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [boven/midden/onder] in de zone [.. mm] groot, [glad/gelobd/gespiculeerd] begrensde, ronde opaciteit. Verkalking [niet gezien]. Hilaire of mediastinale verbreding [afwezig/aanwezig]. Pleuravocht [afwezig/aanwezig]. Destructie van de aangrenzende ribben [niet gezien].

Conclusie: [Rechts/Links] long [zone]: [.. mm] massalaesie. Voor verdere beoordeling wordt een CT-thorax met contrast aanbevolen.

013 PA-thoraxfoto · Caviterende laesie

Wanneer gebruik je het: Casussen waarin je een omwande laesie met lucht erin ziet.

Techniek: Staande PA [± lateraal] thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [boven/midden/onder] wand in de zone [dun/dik, onregelmatig] caviterende laesie; daarin een lucht-vloeistofspiegel [aanwezig/afwezig]. Daaromheen [consolidatie/nodulaire opaciteiten].

Conclusie: [Rechts/Links] [zone]: caviterende laesie. De differentiaaldiagnose omvat infectieuze processen waaronder tuberculose, longabces en caviterende neoplasie; klinische en microbiologische correlatie en een thorax-CT worden aanbevolen.

014 Thoraxfoto · Ribfractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen met een corticale onderbreking na een thoraxtrauma.

Techniek: PA-thoraxfoto [± ribfoto].

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [..]. rib [anterieur/lateraal/posterieur] in de boog [niet-gedisloceerd/gedisloceerd] fractuurlijn. Geen pneumothorax gezien. Pleuravocht passend bij hematothorax [afwezig/aanwezig]. Subcutaan emfyseem [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Rechts/Links] [..]. ribfractuur; geen bijkomende pneumothorax gezien. De sensitiviteit van de röntgenfoto voor ribfracturen is beperkt.

015 Bedside thoraxfoto · Positie endotracheale tube

Wanneer gebruik je het: IC- en SEH-patiënten bij wie na intubatie controle van de tubetip wordt gevraagd.

Techniek: Bedside AP-thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Het uiteinde van de endotracheale tube ligt ten opzichte van de carina [.. cm] boven, in de middenlijn van de trachea. [Tip van de maagsonde projecteert ter plaatse van de maag.] Geen pneumothorax. [Geen nieuw ontstane opaciteit.]

Conclusie: De tip van de endotracheale tube ligt ten opzichte van de carina [.. cm] boven [in goede positie]. / Tip van de tube [rechter hoofdbronchus] in de projectie van; aan het klinische team [uur] gemeld.

016 Bedside thoraxfoto · Centraal veneuze katheter

Wanneer gebruik je het: Controle van tippositie en pneumothorax na plaatsing van een CVC.

Techniek: Bedside AP-thoraxfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [v. jugularis interna/v. subclavia] de tip van de via de route ingebrachte centraalveneuze katheter [vena cava superior/cavo-atriale overgang] in de projectie van. Geen pneumothorax gezien. Geen nieuwe verbreding van het mediastinum.

Conclusie: Tip van de CVC [vena cava superior] in de projectie van. Geen procedure-gerelateerde pneumothorax gezien.

017 Thoraxfoto · Positie van de neusmaagsonde

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij controle van de tip van de NG-sonde wordt gevraagd voordat met voeding wordt gestart.

Techniek: Bedside AP-opname van thorax en bovenbuik.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: De maagsonde verloopt in de middellijn langs het traject van de oesofagus, passeert het diafragma en de tip projecteert in het linkerbovenkwadrant ter plaatse van de maag.

Conclusie: Tip van de maagsonde projecteert ter plaatse van de maag. / Tip van de sonde [rechter hoofdbronchus/oesofagus] in de projectie van, niet in de juiste positie; vóór gebruik aan het klinische team [uur] gemeld.

018 Staande röntgenfoto · Pneumoperitoneum

Wanneer gebruik je het: Casussen met vrije lucht onder het diafragma bij een acute buik. Vereist spoedmelding.

Techniek: Staande thoraxfoto / staande buikoverzichtsfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Bilateraal] onder de diafragmakoepel is een radiolucent gebied zichtbaar, passend bij vrije lucht.

Conclusie: Pneumoperitoneum (vrije lucht). Zonder recente chirurgische ingreep of interventie in de voorgeschiedenis wordt spoedige klinische evaluatie aanbevolen in verband met perforatie van een hol orgaan. Het klinisch team [uur] gemeld.

019 Staande buikoverzichtsfoto · Dunnedarmobstructie

Wanneer gebruik je het: Casussen die zich presenteren met braken, distensie en het niet kunnen lozen van windjes en ontlasting.

Techniek: Staande buikoverzichtsfoto [± liggend].

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Centraal gelegen gedilateerde dunnedarmlissen met zichtbare valvulae conniventes en lucht-vloeistofspiegels op verschillende hoogte. Gas in het colon [verminderd/niet zichtbaar]. Geen vrije lucht onder het diafragma.

Conclusie: Bevindingen passend bij dunnedarmobstructie. Voor beoordeling van niveau, oorzaak en complicaties wordt een CT-abdomen met contrast aanbevolen.

020 Buikoverzichtsfoto · Verdenking op sigmoïdvolvulus

Wanneer gebruik je het: Casussen met een reusachtige colonlis, vooral bij oudere patiënten met uitgesproken distensie.

Techniek: Staand [± liggend] buikoverzichtsfoto.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Uitgesproken gedilateerde colonlis in de vorm van een omgekeerde U, zonder haustratie, die van het bekken naar het bovenkwadrant reikt (koffieboonteken).

Conclusie: Bevindingen passend bij een sigmoïdvolvulus. Spoedige klinische evaluatie aanbevolen; CT kan worden overwogen ter bevestiging en beoordeling van complicaties. Het klinisch team [uur] gemeld.

021 Buikoverzichtsfoto urinewegen · Radio-opake steen

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij flankpijn een opaciteit ziet in de nier of langs het traject van de ureter.

Techniek: Buikoverzichtsfoto van de urinewegen (BOZ/KUB).

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [nier/traject van de ureter/pyelum] in de projectie van [.. mm] grote opake densiteit.

Conclusie: [Rechts/Links] [lokalisatie] in de projectie van een densiteit die kan passen bij een radio-opake steen. Voor onderscheid met een flebolith en beoordeling van obstructie wordt correlatie met echografie of blanco CT aanbevolen.

022 Röntgenfoto pols · Distale radiusfractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen met een fractuurlijn in de distale radius na een val op de hand.

Techniek: [Rechts/Links] röntgenfoto's van de pols, AP en lateraal.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] in de metafyse van de distale radius, tot aan het gewrichtsoppervlak [uitbreidend/niet uitbreidend], [dorsaal/volair] fractuurlijn met angulatie. Fractuur van de processus styloideus ulnae [aanwezig/afwezig]. Radiale verkorting [aanwezig/afwezig].

Conclusie: [Rechts/Links] distale radiusfractuur ([intra-articulair/extra-articulair], [dorsaal/volair] met angulatie).

023 Röntgenfoto pols · Scaphoïdfractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen met een fractuurlijn in het scaphoïd bij patiënten met drukpijn in de tabatière anatomique.

Techniek: [Rechts/Links] röntgenfoto's van de pols, AP, lateraal en scafoïdopnamen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Scafoïd [taille/proximale pool/distale pool] ter hoogte van [fijn/gedisloceerd] fractuurlijn. Scafoïdvetstreep [verstreken/behouden].

Conclusie: [Rechts/Links] scafoïd [taille] fractuur. Bij fracturen van de proximale pool wordt orthopedische follow-up aanbevolen vanwege het risico op avasculaire necrose.

024 Röntgenfoto heup · Collumfractuur

Wanneer gebruik je het: Patiënten, vooral ouderen, met heuppijn en onvermogen om te lopen na een val.

Techniek: Bekken AP en [rechts/links] laterale röntgenfoto's van de heup.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] in de femurhals [subcapitaal/transcervicaal/basocervicaal] fractuurlijn; [gedisloceerd/niet-gedisloceerd, geïmpacteerd]. Heupgewricht [passend].

Conclusie: [Rechts/Links] femurhalsfractuur ([gedisloceerd/niet-gedisloceerd]). Bij een negatieve röntgenfoto en hoge klinische verdenking wordt MRI of CT aanbevolen in verband met een occulte fractuur.

025 Röntgenfoto schouder · Glenohumerale luxatie

Wanneer gebruik je het: Casussen na schoudertrauma waarbij de humeruskop niet congruent is met de glenoïd.

Techniek: [Rechts/Links] schouder AP en [scapulaire Y/axiaal] röntgenfoto's.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] de humeruskop ten opzichte van de glenoïd [anteroinferieur/posterieur] in het deel; de glenohumerale congruentie is verstoord. Fractuur van het tuberculum majus [afwezig/aanwezig]. [Hill-Sachs/Bankart] botveranderingen passend bij [niet gezien/wel gezien].

Conclusie: [Rechts/Links] [anterieur/posterieur] glenohumerale luxatie. Een controleröntgenfoto na repositie wordt aanbevolen.

026 Röntgenfoto enkel · Malleolusfractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen met een fractuurlijn in de malleoli na een verzwikking.

Techniek: [Rechts/Links] röntgenfoto's van de enkel: AP, mortise en lateraal.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [laterale malleolus/distale fibula] ter hoogte van, van de syndesmose [onder/ter hoogte van/boven] [schuin/transversaal] fractuurlijn. Fractuur van de mediale malleolus [aanwezig/afwezig]. Gewrichtsspleet van de mortise [symmetrisch/mediaal verwijd]. Wekedelenzwelling.

Conclusie: [Rechts/Links] [laterale malleolus] fractuur; malleolaire vork [behouden/verwijd].

027 Röntgenfoto onderbeen · Tibiaschachtfractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je na hoogenergetisch trauma een fractuur van de tibiaschacht ziet.

Techniek: [Rechts/Links] röntgenfoto's van het cruris AP en lateraal (inclusief knie en enkel).

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] tibia [proximaal/midden/distaal] in het derde deel van de schacht [transversaal/schuin/spiraal/comminutief] fractuur; [.. mm] dislocatie en [anterieur/posterieur] angulatie. Fibula [intact/fractuur]. Lucht in de weke delen [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Rechts/Links] tibiaschachtfractuur ([type fractuur]); fibula [intact/fractuur]. Bij lucht in de weke delen wordt klinische correlatie aanbevolen in verband met een open fractuur.

028 Röntgenfoto knie · Artrose

Wanneer gebruik je het: Patiënten met chronische kniepijn zonder acuut trauma.

Techniek: [Rechts/Links] knie [staand] AP- en laterale röntgenfoto's.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] in de knie [mediaal/lateraal] vernauwing van de tibiofemorale gewrichtsspleet, marginale osteofyten en subchondrale sclerose. Geen acute fractuur gezien.

Conclusie: [Rechts/Links] in de knie [met nadruk op het mediale compartiment] degeneratieve veranderingen (artrose). Geen acute ossale pathologie vastgesteld.

029 Röntgenfoto elleboog (kind) · Supracondylaire humerusfractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen met een fat pad sign of fractuurlijn bij kinderen met elleboogpijn na een val.

Techniek: [Rechts/Links] röntgenfoto's van de elleboog, AP en lateraal.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Op de laterale foto is het anterieure vetkussen geëleveerd en is het posterieure vetkussen zichtbaar. De anterieure humeruslijn [gaat niet door het middelste derde van het capitellum]. In de supracondylaire regio [fijn/gedisloceerd] fractuurlijn [zichtbaar/niet duidelijk te onderscheiden].

Conclusie: [Rechts/Links] supracondylaire humerusfractuur ([gedisloceerd/niet-gedisloceerd]). Ook als de fractuurlijn niet zichtbaar is, is het posterieure fat pad sign significant voor een occulte fractuur; orthopedische beoordeling aanbevolen.

030 Röntgenfoto · Ingeslikt radio-opaak corpus alienum

Wanneer gebruik je het: Casussen met een voorgeschiedenis van het inslikken van een corpus alienum, vooral kinderen.

Techniek: AP-opname van hals, thorax en abdomen **[± lateraal]** röntgenfoto.

Vergelijking: **[datum]** vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: **[Bovenste/middelste/distale deel van de oesofagus/maag/dunne darm]** in de projectie van **[.. mm]** groot radiopaak corpus alienum. Dubbele ring / dubbele contour **[aanwezig/afwezig]**. Geen vrije lucht gezien.

Conclusie: **[Lokalisatie]** in de projectie van een radio-opaak corpus alienum. Ligging in de oesofagus of verdenking op een knoopcelbatterij geldt als spoed; aan het klinische team **[uur]** gemeld. Radiolucente corpora aliena zijn mogelijk niet zichtbaar op de röntgenfoto.

DEEL 2

CT

35 sjablonen: 4 normaal, 31 veelvoorkomende bevindingen tijdens dienst en in de routine.

031 Blanco CT hersenen · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Casussen zonder pathologie bij hoofdpijn, syncope of licht schedeltrauma.

Techniek: Blanco CT hersenen; axiale coupes beoordeeld in hersen- en botvenster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen intracraniële bloeding, massa-effect of middenlijnverschuiving gezien. De grijze-wittestofdifferentiatie is behouden. Ventrikelsysteem en sulci zijn van een bij de leeftijd passende wijdte. De basale cisternen zijn open. Geen fractuur van het calvarium gezien. De afgebeelde paranasale sinussen en mastoïdcellen zijn belucht.

Conclusie: Geen acute intracraniële pathologie op blanco CT hersenen. Een vroeg ischemisch CVA is op blanco CT mogelijk niet zichtbaar; bij aanhoudende klinische verdenking kan MRI-DWI worden overwogen.

032 CT cervicale wervelkolom (trauma) · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Casussen na trauma met de vraag naar cervicaal botletsel waarbij je geen pathologie ziet.

Techniek: Blanco CT cervicale wervelkolom; sagittale en coronale reconstructies, bot- en wekedelenvenster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Stand van de cervicale wervels behouden. Geen acute fractuur of luxatie. Facetgewrichten congruent. Craniocervicale overgang normaal. Dikte van de prevertebrale weke delen normaal.

Conclusie: Op de CT van de cervicale wervelkolom geen acute traumatische botpathologie vastgesteld. Ligamentair letsel kan met CT niet volledig worden uitgesloten; bij neurologische uitval wordt MRI aanbevolen.

033 Thorax-CT · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Thorax-CT's op routine- of niet-oncologische indicatie waarop je geen pathologie ziet.

Techniek: [Met IV-contrast/Zonder contrast] CT-thorax; beoordeeld in mediastinum- en longvenster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen lymfeklieren van pathologische grootte in het mediastinum. Normale hartgrootte, geen pericardeffusie. Grote vaten met normaal kaliber. Geen consolidatie, massa of significante nodus in het longparenchym. Geen pleuravocht of pneumothorax. Geen pathologie in de afgebeelde bovenbuik en botstructuren.

Conclusie: Op de thorax-CT geen significante pathologie vastgesteld.

034 CT abdomen-bekken · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: CT's van abdomen-bekken met contrast zonder acute pathologie bij buikpijn.

Techniek: CT abdomen-bekken met iv-contrast, portaal-veneuze fase. Oraal contrast [toegediend/niet toegediend].

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Lever, milt, pancreas, bijnieren en nieren van normale grootte en densiteit; geen focale laesie. Galblaas normaal; intra- en extrahepatische galwegen niet gedilateerd. Geen dilatatie of wandverdikking van de darmlissen. Appendix [normaal van aspect/niet duidelijk te onderscheiden, geen tekenen van ontsteking in het rechteronderkwadrant]. Geen vrij vocht en geen vrije lucht. Geen lymfeklieren van pathologische grootte. Blaas normaal. Geen lytische of blastische laesies in de botstructuren.

Conclusie: Geen acute pathologie op CT abdomen-bekken.

035 Blanco CT hersenen · Epiduraal hematoom

Wanneer gebruik je het: Casussen met een biconvexe hyperdense collectie na schedeltrauma. Spoedmelding.

Techniek: Blanco CT hersenen; hersen- en botvenster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [temporaal/pariëtaal/frontaal] in de regio, de schedelnaden niet overschrijdend, biconvex (lensvormig), op de dikste plaats [.. mm] gemeten hyperdense extra-axiale collectie. In het aangrenzende calvarium [lineaire fractuurlijn]. Midline shift [.. mm]. Basale cisternen [vrij/verstreken].

Conclusie: [Rechts/Links] [regio] acuut epiduraal hematoom; [.. mm] middenlijnverschuiving. Spoedbevinding; aan het klinische team [uur] gemeld.

036 Blanco CT hersenen · Subduraal hematoom

Wanneer gebruik je het: Casussen met een sikkelvormige extra-axiale collectie, vooral bij oudere patiënten en patiënten die antistolling gebruiken.

Techniek: Blanco CT hersenen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] langs de convexiteit van de hemisfeer, de suturen overschrijdend, sikkelvormig, [hyperdens/isodens/hypodens/gemengde densiteit] subdurale collectie; op het dikste punt [.. mm]. Verstreken sulci, compressie van de ipsilaterale laterale ventrikel en [.. mm] middenlijnverschuiving.

Conclusie: [Rechts/Links] [acuut/subacuut/chronisch/acuut op chronisch] subduraal hematoom; massa-effect [aanwezig/afwezig]. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

037 Blanco CT hersenen · Subarachnoïdale bloeding

Wanneer gebruik je het: Casussen met hyperdensiteit in de cisternen bij plotselinge hevige hoofdpijn of na trauma.

Techniek: Blanco CT hersenen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Basale cisternen/fissurae Sylvii/interhemisferische fissuur/corticale sulci] hyperdense subarachnoïdale bloeding in. Intraventriculaire bloeding [afwezig/aanwezig]. Ventrikelverwijding [afwezig/aanwezig]. Parenchymateus hematoom [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Diffuus/Focaal] subarachnoïdale bloeding. Hydrocefalus [afwezig/aanwezig]. Zonder traumaanamnese wordt CT-angiografie aanbevolen in verband met een aneurysma. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

038 Blanco CT hersenen · Intracerebrale bloeding

Wanneer gebruik je het: Casussen met een hyperdens intraparenchymateus hematoom bij een patiënt met acute neurologische uitval.

Techniek: Blanco CT hersenen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [basale ganglia/thalamus/lobair/cerebellair] gelegen, [.. x .. mm] grote hyperdense parenchymateuze bloeding; daaromheen hypodens oedeem. Doorbraak naar de ventrikel [afwezig/aanwezig]. Midline shift [.. mm].

Conclusie: [Rechts/Links] [lokalisatie] acuut intraparenchymateus hematoom. Afhankelijk van de klinische situatie wordt nader onderzoek naar de onderliggende oorzaak aanbevolen. Het klinisch team [uur] gemeld.

039 Blanco CT hersenen · Vroege tekenen van ischemisch CVA

Wanneer gebruik je het: CT's in het kader van het CVA-protocol bij acute focale neurologische uitval.

Techniek: Blanco CT hersenen; aanvullende beoordeling in het stroke-venster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links]
[In het stroomgebied van de MCA/in de insulaire cortex/in de nucleus lentiformis] vervaging van de grijze-wittestofgrens en lichte hypodensiteit; vervaging van de aangrenzende sulci. Geen intracraniële bloeding gezien.

Conclusie: [Rechts/Links] [MCA] stroomgebied bevindingen passend bij vroege acute ischemie; geen intracraniële bloeding. In het kader van het CVA-protocol aan het klinische team [uur] gemeld.

040 Blanco CT hersenen · Hyperdens MCA-teken

Wanneer gebruik je het: Casussen waarin je bij verdenking op een beroerte een duidelijke hyperdensiteit in de MCA ziet vergeleken met de contralaterale zijde.

Techniek: Blanco CT hersenen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] MCA [M1/M2] segment duidelijke hyperdensiteit vergeleken met de contralaterale zijde (hyperdense-arteriesign). Bijkomende vroege ischemische veranderingen [afwezig/aanwezig]. Geen bloeding gezien.

Conclusie: [Rechts/Links] Hyperdens arteriesignaal in de MCA; kan passen bij een acute trombus. Evaluatie met CT-angiografie wordt aanbevolen. Het klinisch team [uur] gemeld.

041 Blanco CT hersenen · Hydrocephalus

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij de ventrikels disproportioneel ten opzichte van de sulci verwijd zijn.

Techniek: Blanco CT hersenen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de laterale en derde ventrikel [en in de vierde ventrikel] duidelijke verwijding, disproportioneel ten opzichte van de sulci. Periventriculaire hypodensiteit [aanwezig/afwezig]. Niveau van de obstructie: [niveau/niet duidelijk te onderscheiden].

Conclusie: [Obstructief/Communicerend] aanwijzingen voor hydrocefalus. Vergeleken met het vorige onderzoek [toename/geen verandering]. Indien acuut ontstaan, aan het klinisch team [uur] gemeld.

042 CT hersenen · Massa en vasogeen oedeem

Wanneer gebruik je het: Casussen met een laesie met massa-effect bij hoofdpijn, epileptische aanval of focale uitval.

Techniek: Blanco [± met IV-contrast] CT van de hersenen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [kwab]: [.. mm] groot [isodens/hyperdens] massalaesie; daaromheen vasogeen oedeem met vingervormige uitlopers. Massa-effect: vervaging van de sulci, [compressie van de ipsilaterale ventrikel], [.. mm] middenlijnverschuiving.

Conclusie: [Rechts/Links] [kwab] massalaesie en perifocaal vasogeen oedeem. Voor karakterisering wordt een MRI van de hersenen met contrast aanbevolen. Aanwijzingen voor herniatie [afwezig/aanwezig; gemeld aan het klinisch team].

043 CT hersenen · Schedelfractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen met een fractuurlijn in het botvenster bij schedeltrauma.

Techniek: Blanco CT hersenen; botvenster en 3D-reconstructie.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [frontaal/pariëtaal/temporaal/occipitaal] in het bot [lineair/impressie] fractuurlijn; mate van impressie [.. mm]. Aangrenzende extra-axiale bloeding [afwezig/aanwezig]. Pneumocephalus [afwezig/aanwezig]. Hematoom van de behaarde hoofdhuid.

Conclusie: [Rechts/Links] [bot] [lineair/impressie] fractuur. Bijkomende intracraniële bloeding [niet gezien/...].

044 CT-pulmonalisangiografie · Longembolie

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je een vullingsdefect ziet op een CT-pulmonalisangiografie aangevraagd bij verdenking op longembolie. Spoedmelding.

Techniek: CT-pulmonalisangiografie. Opacificatie van de arteria pulmonalis [voldoende/onvoldoende].

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links/Bilateraal] [hoofd-/lobaire/segmentale/subsegmentale] vullingsdefecten in de longarteriën. Verhouding rechterventrikel/linkerventrikel [verhoogd/normaal]; in het interventriculaire septum [afvlakking/uitbochting naar links] [aanwezig/afwezig]. Wigvormige consolidatie in de periferie [afwezig/aanwezig; kan passen bij een infarct].

Conclusie: [Bilateraal] acute longembolie. Bevindingen passend bij rechterventrikelbelasting [aanwezig/afwezig]. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

045 Thorax-CT · Incidentele longnodus

Wanneer gebruik je het: Casussen met een incidentele nodus op een CT die om een andere reden is gemaakt.

Techniek: [Met IV-contrast/Zonder contrast] CT-thorax, dunne coupes.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [kwab] [segment]: [.. mm] groot [solide/subsolide/matglas] nodule; [glad/gelobd/gespiculeerd] begrensd. Verkalking [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Rechts/Links] [kwab]: [.. mm] [solide] nodule. De noodzaak en het interval van follow-up moeten samen met het klinische team worden bepaald op basis van het risicoprofiel van de patiënt en de actuele richtlijn die je instelling hanteert.

046 Thorax-CT · Emfyseem

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij een roker of COPD-patiënt gebieden met emfyseem ziet.

Techniek: Blanco CT thorax; longvenster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Bilateraal [met voorkeur voor de bovenkwabben] [centrilobulair/paraseptaal/panlobulair] gebieden met emfyseem. [Bullae.] Geen consolidatie of massa gezien.

Conclusie: [Centrilobulair] emfyseem. Geen acute parenchympathologie.

047 Thorax-CT · Matglasdensiteiten

Wanneer gebruik je het: Casussen met matglasgebieden bij dyspneu, koorts of hypoxemie.

Techniek: [Zonder contrast/Met IV-contrast] CT-thorax; longvenster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Bilateraal [perifeer/centraal/diffuus], [met voorkeur voor de onderkwabben] matglasdensiteiten. Interlobulaire septumverdikking [aanwezig (crazy paving)/afwezig]. Pleuravocht [afwezig/aanwezig].

Conclusie: Bilaterale matglasdensiteiten. De differentiaaldiagnose omvat virale en atypische infecties, longoedeem, alveolaire bloeding en andere inflammatoire processen; klinische en laboratoriumcorrelatie aanbevolen.

048 Thorax-CT · Pneumothorax

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je na trauma of een ingreep op CT lucht in de pleuraholte ziet.

Techniek: Thorax-CT; longvenster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] in de hemithorax [anterieur/apicaal/diffuus] gelegen, op het dikste punt [.. mm] pneumothorax. Mediastinale verschuiving [afwezig/aanwezig]. Pneumomediastinum [afwezig/aanwezig]. Subcutaan emfyseem [afwezig/aanwezig]. Ribfracturen [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Rechts/Links] [klein/matig/groot] pneumothorax. Aan het klinische team [uur] gemeld.

049 CT-angiografie · Aortadissectie

Wanneer gebruik je het: Casussen met een intimaflap bij acuut ontstane borst- of rugpijn. Spoedmelding.

Techniek: Blanco en arteriële fase CT-angiografie.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Vanaf de aorta ascendens/distaal van de linker a. subclavia] beginnend [niveau] reikende intimaflap; een echt en een vals lumen zijn zichtbaar. De dissectie [naar de takken van de boog/truncus coeliacus/AMS/nierarteriën] uitbreiding: [detail]. Pericardeffusie [afwezig/aanwezig]. Mediastinaal hematoom [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Met betrokkenheid van de aorta ascendens (Stanford A)/zonder betrokkenheid van de aorta ascendens (Stanford B)] aortadissectie. Spoedbevinding; het klinisch team [uur] gemeld.

050 CT abdomen · Aneurysma van de aorta abdominalis

Wanneer gebruik je het: Casussen met verwijding van de aorta bij buik- of rugpijn of als toevalsbevinding.

Techniek: [CT-angiografie met contrast/CT abdomen in portaal-veneuze fase].

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de infrarenale abdominale aorta maximaal [.. mm] met een diameter van [fusiform/sacculair] aneurysmatische verwijding; wandverkalkingen en [muurtrombus]. Afstand tot de nierarteriën [.. mm]. Periaortaal hematoom of vetinfiltratie (fat stranding) [niet gezien/wel gezien].

Conclusie: Infrarenaal abdominaal aorta-aneurysma, maximale diameter [.. mm]. Bevinding passend bij ruptuur [niet gezien/wel gezien]. Bij tekenen van ruptuur als spoedeisende bevinding aan het klinisch team [uur] gemeld.

051 CT abdomen · Acute appendicitis

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij pijn in het rechteronderkwadrant een ontstoken appendix ziet.

Techniek: CT abdomen-bekken met iv-contrast, portaal-veneuze fase.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Appendix [.. mm] met een diameter van, verdikte wand en toegenomen aankleuring; infiltratie van het omliggende vet. Appendicoliet [aanwezig/afwezig]. Periappendiculair vocht, abces of vrije lucht [afwezig/aanwezig].

Conclusie: Bevindingen passend bij acute appendicitis. Bevinding passend bij perforatie of abces [niet gezien/wel gezien]. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

052 CT abdomen · Acute diverticulitis

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij pijn in het linkeronderkwadrant ontsteking ziet van een segment met divertikels.

Techniek: CT abdomen-bekken met iv-contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Sigmoïd/Descendens] divertikels in het colon; [.. cm] lang segment wandverdikking en infiltratie van het pericolische vet. Pericolische vrije lucht [afwezig/aanwezig]. Abces [afwezig/aanwezig, .. mm].

Conclusie: [Sigmoïd] in het colon acute [ongecompliceerd/gecompliceerd] diverticulitis. Beoordeling van het colon na de acute fase wordt aan het klinisch oordeel overgelaten.

053 CT abdomen · Dunnedarmobstructie

Wanneer gebruik je het: Casussen met verdenking op obstructie op de röntgenfoto of met braken en distensie.

Techniek: CT abdomen-bekken met iv-contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Gedilateerde dunnedarmlissen met distaal daarvan gecollabeerde lissen; overgangszone [rechteronderkwadrant/bekken/...]. Mogelijke oorzaak: [adhesie/hernia/massa/niet duidelijk te onderscheiden]. Verminderde aankleuring van de darmwand, mesenteriaal oedeem en vrij vocht [afwezig/aanwezig]. Pneumatosis [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Regio]: mechanische dunnedarmobstructie met overgangszone; mogelijke oorzaak [oorzaak]. Bevinding passend bij ischemie [niet gezien/wel gezien]. Bij tekenen van ischemie als spoedeisende bevinding aan het klinisch team [uur] gemeld.

054 CT abdomen · Pneumoperitoneum (perforatie)

Wanneer gebruik je het: Casussen met vrije lucht op CT bij een acute buik. Spoedmelding.

Techniek: CT abdomen-bekken met iv-contrast; aanvullende beoordeling in het longvenster.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Voor de lever/periportaal/in het mesenterium] vrije lucht. Vrij vocht [afwezig/aanwezig]. Mogelijke plaats van perforatie: [maag/duodenum/colon]; [wanddefect/focale wandverdikking/omgevende ontsteking].

Conclusie: Pneumoperitoneum; [mogelijke lokalisatie] passend bij perforatie. Spoedbevinding; aan het klinische team [uur] gemeld.

055 Blanco CT · Ureterstenen

Wanneer gebruik je het: CT volgens steenprotocol bij verdenking op nierkoliek.

Techniek: Blanco CT abdomen-bekken (stenenprotocol).

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] ureter [in het proximale/middelste/distale deel/op de ureterovesicale overgang] [.. mm] steen. In de proximale ureter en het verzamelsysteem [licht/matig/uitgesproken] dilatatie; infiltratie van het perirenale vet. In de contralaterale nier [geen steen/steen van .. mm].

Conclusie: [Rechts/Links] [distaal] in de ureter [.. mm] steen en [licht] hydro-ureteronefrose.

056 CT abdomen · Acute pancreatitis

Wanneer gebruik je het: Casussen met klinisch en biochemisch vermoeden van pancreatitis waarbij beoordeling van complicaties wordt gevraagd.

Techniek: CT abdomen met iv-contrast, [pancreatische fase en] portaalveneuze fase.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Pancreas [diffuus/focaal] oedemateus; infiltratie van het peripancreatische vet en vocht. Niet-aankleurend gebied in het parenchym [afwezig/aanwezig]. Galstenen [aanwezig/afwezig]. Vena lienalis en vena portae [open/verdenking trombus].

Conclusie: Acuut [interstitieel oedemateus/necrotiserend] aanwijzingen voor pancreatitis. Complicatie: [afwezig/...].

057 CT abdomen · Meerdere leverlaesies verdacht voor metastasen

Wanneer gebruik je het: Casussen bij een oncologische patiënt of waarbij je voor het eerst meerdere leverlaesies ziet.

Techniek: CT abdomen met iv-contrast, portaal-veneuze fase.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In beide leverkwabben, de grootste in segment [..]: [.. mm] grote, meerdere hypodense laesies met perifere aankleuring.

Conclusie: Meerdere leverlaesies, mogelijk passend bij metastasen. Ten opzichte van het vorige onderzoek [nieuw/toegenomen/stabiel]. Klinische en zo nodig histopathologische correlatie aanbevolen.

058 Trauma-CT · Miltletsel

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij stomp buiktrauma een laceratie of hematoom van de milt ziet. Spoedmelding.

Techniek: Trauma-CT met iv-contrast, arteriële en portaal-veneuze fase.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de milt [.. mm] lange laceratie / subcapsulair hematoom. Perisplenisch en [pelvien] vrij vocht (passend bij hemoperitoneum). Actieve contrastextravasatie [afwezig/aanwezig].

Conclusie: Miltletsel ([laceratie/hematoom]) en hemoperitoneum. Bevinding passend bij actieve bloeding [afwezig/aanwezig]. De gradering gebeurt volgens het systeem dat je instelling hanteert. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

059 CT abdomen · Eenvoudige levercyste

Wanneer gebruik je het: Incidentele, typisch ogende cysteuze leverlaesies.

Techniek: CT abdomen met iv-contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Leversegment [..]: [.. mm] grote, scherp begrensde laesie met vochtdensiteit, dunne wand en zonder aankleuring.

Conclusie: Leversegment [..]: laesie passend bij een eenvoudige cyste.

060 CT abdomen · Acute cholecystitis

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij pijn in het rechterbovenkwadrant op CT ontsteking van de galblaas ziet.

Techniek: CT abdomen met iv-contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Galblaas gedistendeerd, wand verdikt; pericholecystitisch vocht en vetinfiltratie. In het lumen [steen te onderscheiden/geen steen te onderscheiden]. Gas in de wand, verlies van aankleuring of perforatie [afwezig/aanwezig].

Conclusie: Bevindingen passend bij acute cholecystitis. De sensitiviteit van CT voor galstenen is beperkt; correlatie met echo aanbevolen.

061 CT wervelkolom · Acute wervelfractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je na trauma bij rug- of lage rugpijn een fractuur van een wervellichaam ziet.

Techniek: Blanco [thoracolumbaal] CT; sagittale en coronale reconstructies.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [L1] in het wervellichaam [compressie/burst] fractuur; hoogteverlies anterieur. Achterwand [behouden/vernauwing van het wervelkanaal door een geretropulseerd fragment]. Posterieure elementen [intact/fractuur].

Conclusie: [L1] in de wervel acuut ogende [compressie/burst] fractuur; in het wervelkanaal [vernauwing aanwezig/afwezig]. Bij neurologische uitval wordt MRI aanbevolen.

062 CT neusbijholten · Sinusitis

Wanneer gebruik je het: Sinus-CT's bij klachten van chronische of recidiverende sinusitis.

Techniek: Blanco CT paranasale sinussen; coronale reconstructie.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links/Bilateraal] [maxillair/ethmoïdaal/frontaal/sfenoïdaal] in de sinus [slijmvliesverdikking/lucht-vloeistofspiegel/volledige opvulling]. Ostiomeataal complex [open/gesloten]. Geen botdestructie, orbitale of intracraniële uitbreiding gezien.

Conclusie: [Lokalisatie] bevindingen passend bij sinusitis. Een lucht-vloeistofspiegel kan passen bij acute sinusitis; klinische correlatie wordt aanbevolen.

063 CT abdomen · Incidentele bijniernodus

Wanneer gebruik je het: Casussen met een incidentele nodus in de bijnier op een CT die om een andere reden is gemaakt.

Techniek: [Zonder contrast/Met IV-contrast] CT van het abdomen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] in de bijnier [.. mm] grote, scherp begrensde nodus; [blanco densiteit .. HU/karakterisering bij onderzoek met contrast niet mogelijk].

Conclusie: [Rechts/Links] bijniernodus. De noodzaak van karakterisering en follow-up moet in overleg met het klinisch team volgens de actuele richtlijn worden bepaald; zo nodig wordt een CT volgens bijnierprotocol of een chemical-shift-MRI aanbevolen.

064 Thorax-CT · Pneumonie (consolidatie)

Wanneer gebruik je het: CT's bij pneumonieën die op de röntgenfoto onduidelijk zijn of waarbij complicaties worden vermoed.

Techniek: [Zonder contrast/Met IV-contrast] CT-thorax.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [kwab]: consolidatie met luchtbronchogram; daaromheen matglasdensiteiten. Pleuravocht [afwezig/aanwezig]. In het mediastinum [reactief van aspect] lymfeklieren. Cavitatie of abces [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Rechts/Links] [kwab] consolidatie; kan passen bij een infectieus proces (pneumonie). Controle na behandeling wordt aanbevolen volgens klinisch oordeel.

065 Trauma-CT · Hemoperitoneum

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij stomp buiktrauma vrij vocht ziet.

Techniek: Trauma-CT met iv-contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Ruimte van Morison/perisplenisch/bekken] vrij vocht in; densiteit [.. HU], passend bij hemoperitoneum. Letsel van de solide organen [niet gezien/...]. In de darmwand en het mesenterium [geen pathologie gezien/...].

Conclusie: [Weinig/Matig/Veel] hoeveelheid hemoperitoneum. Als er geen letsel van solide organen wordt gezien, wordt klinische follow-up aanbevolen met het oog op darm- of mesenteriaal letsel. Aan het klinische team [uur] gemeld.

DEEL 3

MRI

25 sjablonen: 3 normaal, 22 veelvoorkomende bevindingen in de routine en tijdens dienst.

066 MRI hersenen · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Hersen-MRI's zonder pathologie bij onderzoek naar hoofdpijn, duizeligheid of epilepsie.

Techniek: MRI hersenen; axiale T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI/T2*], [T1 na contrast] sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen signaalafwijkingen in het hersenparenchym. Geen diffusierestrictie op DWI. Ventrikelsysteem en sulci passend bij de leeftijd. Middenlijnstructuren normaal. [Na contrast geen pathologische aankleuring.] Flow voids zichtbaar in de hoofdarteriën.

Conclusie: Geen significante pathologie op MRI hersenen.

067 Lumbale MRI · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Casussen zonder pathologie van discus, zenuwwortel of kanaal bij lage rugpijn.

Techniek: Lumbale MRI; sagittale T1-, T2-, STIR- en axiale T2-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Lumbale lordose behouden, normale stand van de wervels. Hoogte van de wervellichamen en beenmergsignaal normaal. Geen duidelijke degeneratie of herniatie van de tussenwervelschijven. Wervelkanaal en neuroforamina vrij. Conus medullaris op normale hoogte en met normaal signaal.

Conclusie: Op de lumbale MRI geen significante pathologie vastgesteld.

068 MRI knie · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Casussen zonder structurele pathologie bij kniepijn of knietrauma.

Techniek: [Rechts/Links] MRI van de knie; PD-sequenties met vetsuppressie, T1- en T2-sequenties, drie vlakken.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen signaalverhoging in de menisci die wijst op een scheur. Voorste en achterste kruisband, collaterale banden en extensormechanisme normaal. Geen beenmergoedeem. Gewrichtskraakbeen behouden. Geen duidelijke gewrichtseffusie.

Conclusie: [Rechts/Links] geen significante pathologie vastgesteld op de MRI van de knie.

069 MRI hersenen · Acuut infarct (DWI)

Wanneer gebruik je het: Casussen met diffusierestrictie bij acute focale uitval. Melden.

Techniek: MRI hersenen; DWI/ADC-, FLAIR-, T2- en SWI/T2*-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [regio]: gebied met diffusierestrictie, hyperintens op DWI en hypo-intens op de ADC-map. Op FLAIR [geen duidelijke signaalverandering/lichte hyperintensiteit]. Hemorragische transformatie [niet gezien/wel gezien].

Conclusie: [Rechts/Links] [arterie] stroomgebied acuut infarct. Aan het klinische team [uur] gemeld.

070 MRI hersenen · Demyeliniserende plaques

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je laesies in de witte stof ziet bij neuritis optica, sensibiliteitsstoornis of MS-follow-up.

Techniek: MRI hersenen; FLAIR (bij voorkeur 3D), T2, T1, DWI, T1 na contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Periventriculair, [juxtacorticaal], [infratentorieel] gelegen, ovoïde T2/FLAIR-hyperintense laesies, loodrecht op het corpus callosum georiënteerd. Na contrast [.. aankleuring in de laesie/geen aankleuring].

Conclusie: Wittestoflaesies mogelijk passend bij een demyeliniserende aandoening. Nieuwe of aankleurende laesies ten opzichte van het vorige onderzoek [afwezig/aanwezig]. De diagnose moet worden beoordeeld in samenhang met de klinische bevindingen en de actuele diagnostische criteria.

071 MRI hersenen · Ringvormig aankleurende intra-axiale massa

Wanneer gebruik je het: Aankleurende parenchymateuze laesies met massa-effect en oedeem.

Techniek: MRI hersenen met contrast; DWI, [perfusie], SWI-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [kwab]: [.. mm] grote, onregelmatige ringvormig aankleurende massa met centrale necrose; daaromheen vasogeen oedeem en massa-effect. Uitbreiding naar het corpus callosum [afwezig/aanwezig]. Uitgesproken diffusierestrictie centraal [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Rechts/Links] [kwab] ringvormig aankleurende intra-axiale massa; in de differentiaaldiagnose worden in de eerste plaats een hooggradige gliale tumor en een metastase overwogen. Bij uitgesproken centrale diffusierestrictie moet een abces in de differentiaaldiagnose worden opgenomen.

072 MRI hersenen · Meningeoom

Wanneer gebruik je het: Duraal gebaseerde, homogeen aankleurende extra-axiale massa's.

Techniek: MRI hersenen met contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Regio]: durale basis, [.. mm] grote, extra-axiale massa, isointens op T1, homogeen aankleurend; dural tail sign. Oedeem in het aangrenzende parenchym [afwezig/aanwezig]. Massa-effect [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Regio]: extra-axiale massa passend bij een meningeoom.

073 MRI hypofyse · Hypofyseadenoom

Wanneer gebruik je het: Hypofyse-MRI's wegens hormonale stoornissen of gezichtsvelduitval.

Techniek: MRI hypofyse; dunne coronale en sagittale T1-, T2- en dynamische contrastseries.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de hypofyse [.. mm] grote laesie die in dynamische series later aankleurt dan de normale klier. Suprasellaire uitbreiding [afwezig/aanwezig]; compressie van het chiasma opticum [afwezig/aanwezig]. Invasie van de sinus cavernosus [verdacht/afwezig]. Hypofysesteel [in de middellijn/gedevieerd].

Conclusie: Hypofyse [micro/macro] adenoom passende laesie. Endocrinologische correlatie aanbevolen.

074 MRI hersenen · Hersenabces

Wanneer gebruik je het: Casussen met een gladwandige ringvormig aankleurende laesie bij koorts en focale uitval. Melden.

Techniek: MRI hersenen met contrast; inclusief DWI/ADC.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Lokalisatie]: [.. mm] grote laesie met dunne, gladde ringvormige aankleuring; de inhoud toont duidelijke diffusierestrictie op DWI. Omgevend vasogeen oedeem.

Conclusie: Bevindingen passend bij een hersenabces. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

075 MRI hersenen en MR-venografie · Sinustrombose

Wanneer gebruik je het: Patiënten met hoofdpijn, epileptische aanvallen of papiloedeem, vooral met risicofactoren. Melden.

Techniek: MRI hersenen en MR-venografie met en zonder contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Sinus sagittalis superior/transversus/sigmoideus] in de sinus verlies van de normale flow void en signaal passend bij trombus; op MR-venografie vullingsdefect/afwezige flow. In het aangrenzende parenchym veneus infarct of bloeding [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Sinus] trombose. Aan het klinische team [uur] gemeld.

076 MRI hersenen · Chronische small vessel disease

Wanneer gebruik je het: Aspecifieke witte-stoflaesies bij oudere patiënten of patiënten met vasculaire risicofactoren.

Techniek: MRI hersenen; FLAIR-, T2- en DWI-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Bilaterale punctiforme, deels confluerende T2/FLAIR-hyperintensiteiten periventriculair en in de diepe witte stof. Geen diffusierestrictie op DWI. [Chronische lacunaire infarcten.]

Conclusie: Wittestofafwijkingen mogelijk passend bij chronische small vessel disease. Geen acuut infarct.

077 Lumbale MRI · Hernia nuclei pulposi

Wanneer gebruik je het: Lumbale MRI's bij lage rugpijn en beenpijn (radiculopathie).

Techniek: Lumbale MRI; sagittale T1-, T2- en axiale T2-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: L [4-5] T2-signaalverlies en hoogteverlies van de discus; [rechts/links] [paramediaan/foraminaal] [protrusie/extrusie] herniatie. [Rechts/Links] [L5] in de zenuwwortel [contact/compressie]. Wervelkanaal [open/vernauwd]. Neuroforamina [open/vernauwd].

Conclusie: L [4-5] [rechts paramediaan] discus [extrusie]; [L5] op de zenuwwortel [compressie].

078 Cervicale MRI · Disco-osteofytair complex

Wanneer gebruik je het: Cervicale MRI's bij nek- en armpijn of gevoelloosheid.

Techniek: Cervicale MRI; sagittale T1-, T2-, STIR- en axiale T2-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: C [5-6] ter hoogte van [rechts/links] [paramediaan/foraminaal] discus-osteofytcomplex; [rechts/links] vernauwing van het neuroforamen. Signaal van het myelum [normaal/T2-hyperintens].

Conclusie: C [5-6] discus-osteofytcomplex en [rechts] foraminale vernauwing. Signaalverandering in het myelum [afwezig/aanwezig; kan passen bij myelopathie].

079 Thoracale MRI · Epidurale compressie en myelumcompressie

Wanneer gebruik je het: Rugpijn of nieuwe neurologische uitval bij een patiënt met een bekende maligniteit. Spoedmelding.

Techniek: Thoracale met contrast [en de gehele wervelkolom] MRI.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: T [..] in de wervel T1-hypo-intense, aankleurende beenmerglaesie; door epidurale uitbreiding vernauwing van het wervelkanaal en compressie van het myelum. T2-signaaltoename in het myelum [afwezig/aanwezig]. Op de overige niveaus [geen bijkomende laesies/bijkomende laesies].

Conclusie: T [..] ter hoogte van een laesie die kan passen bij epidurale tumoruitbreiding, met compressie van het myelum. Spoedbevinding; aan het klinische team [uur] gemeld.

080 Lumbale MRI · Acute compressiefractuur

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij gering trauma of rugpijn zonder trauma hoogteverlies van een wervellichaam ziet.

Techniek: Lumbale MRI; sagittale T1-, T2- en STIR-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [L1] hoogteverlies van het corpus; beenmergoedeem op STIR. Retropulsie van de achterwand [afwezig/aanwezig]. Betrokkenheid van de posterieure elementen, epidurale of paravertebrale wekedelenmassa [niet gezien/wel gezien].

Conclusie: [L1] in de wervel [acuut/subacuut] compressiefractuur. Aanwijzingen voor een pathologische fractuur [niet gezien/wel gezien; nadere evaluatie aanbevolen].

081 MRI knie · Voorste kruisbandruptuur

Wanneer gebruik je het: Casussen die zich presenteren met instabiliteit en effusie na een pivottrauma.

Techniek: [Rechts/Links] MRI van de knie; PD-sequenties met vetsuppressie en T1-sequenties, drie vlakken.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: in de VKB [proximaal/middendeel] onderbreking van de continuïteit en verlies van het normale lineaire verloop. Botkneuzing van de laterale femurcondyl en het posterolaterale tibiaplateau [aanwezig/afwezig]. Gewrichtseffusie.

Conclusie: [Volledige dikte/Partieel] VKB-ruptuur. Bijkomende [meniscus/collateraal ligament] pathologie [afwezig/aanwezig].

082 MRI knie · Meniscusscheur

Wanneer gebruik je het: Knie-MRI's bij slotklachten, pijn op de gewrichtsspleet of na trauma.

Techniek: [Rechts/Links] MRI van de knie; PD-sequenties met vetsuppressie.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Mediaal/Lateraal] meniscus [achterhoorn/corpus/voorhoorn] in het deel, reikend tot het gewrichtsoppervlak [horizontaal/schuin/radiair/longitudinaal] signaaltoename.
[Gedisloceerd meniscusfragment (bucket handle) niet gezien/wel gezien.]

Conclusie: [Mediaal] meniscus [achterhoorn] [schuin] ruptuur.

083 MRI knie · Botkneuzing

Wanneer gebruik je het: Casussen na trauma met een normale röntgenfoto waarbij je op MRI beenmergoedeem ziet.

Techniek: [Rechts/Links] MRI van de knie; PD-sequenties met vetsuppressie en T1-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Laterale femurcondyl/tibiaplateau], zonder duidelijke fractuurlijn beenmergoedeem op de vetonderdrukte series. Op T1 een lineaire hypo-intense fractuurlijn [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Regio]: botkneuzing; [geen fractuurlijn gezien/subchondrale fractuurlijn gezien].

084 MRI schouder · Rotatorcuffruptuur

Wanneer gebruik je het: MRI's van de schouder aangevraagd voor schouderpijn en krachtverlies bij abductie.

Techniek: [Rechts/Links] MRI van de schouder; PD/T2-sequenties met vetsuppressie en T1-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Van de supraspinatuspees [anterieur] in het deel [articulaire zijde/bursale zijde partieel/volledige dikte] ruptuur; retractie [.. mm]. Atrofie of vervetting van de spier [afwezig/aanwezig]. Vocht in de bursa subacromialis-subdeltoidea.

Conclusie: In de supraspinatuspees [volledige dikte/partiële dikte] ruptuur; retractie [.. mm].

085 MRI heup · Avasculaire necrose van de femurkop

Wanneer gebruik je het: Patiënten met heuppijn, steroïdgebruik of andere risicofactoren.

Techniek: MRI beide heupen; coronale T1, STIR en axiale sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] subchondraal gelegen, landkaartachtig gebied in de femurkop, omgeven door een op T1 hypo-intense lijn; op T2 het double-line sign. Collaps van het gewrichtsoppervlak [afwezig/aanwezig]. Gewrichtseffusie [afwezig/aanwezig]. Contralaterale femurkop [normaal/vergelijkbare verandering].

Conclusie: [Rechts/Links] avasculaire necrose van de femurkop; collaps van het gewrichtsoppervlak [niet gezien/wel gezien].

086 MRI lever · Hemangioom

Wanneer gebruik je het: Karakterisering van een leverlaesie die op echo of CT onduidelijk bleef.

Techniek: Dynamische MRI van de lever met contrast; T2, DWI en arteriële, portaal-veneuze en late fase.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Leversegment [..]: [.. mm], laesie die op T2 duidelijk hyperintens is en in de dynamische series perifere nodulaire en centripetaal progressieve aankleuring toont.

Conclusie: Leversegment [..]: laesie passend bij een typisch hemangioom.

087 MRCP · Choledocholithiasis

Wanneer gebruik je het: Beoordeling van de galwegen bij een patiënt met tekenen van cholestase of galstenen.

Techniek: MRCP; zwaar T2-gewogen 2D- en 3D-sequenties.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de distale ductus choledochus [.. mm] groot vullingsdefect met signal void op T2. Ductus choledochus [.. mm] met een diameter van, in de intrahepatische galwegen [licht] dilatatie. In de galblaas [stenen].

Conclusie: Steen in de distale ductus choledochus (choledocholithiasis) en verwijding van de galwegen. Bij klinische verdenking op cholangitis aan het klinisch team [uur] gemeld.

088 Lumbale MRI · Spondylodiscitis

Wanneer gebruik je het: MRI's met contrast bij koorts, verhoogde ontstekingsparameters en lage rugpijn.

Techniek: Lumbale MRI met contrast; T1, T2, STIR en vetonderdrukte T1 na contrast.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: L[..] T2-hyperintensiteit en aankleuring in de discus; erosie en beenmergoedeem in de aangrenzende eindplaten. [Paravertebraal/epiduraal] [flegmone/abces] [afwezig/aanwezig].

Conclusie: L[..] bevindingen passend bij spondylodiscitis; epiduraal abces [afwezig/aanwezig]. Bij een epiduraal abces aan het klinisch team [uur] gemeld.

089 MRI knie · Popliteale (Baker)cyste

Wanneer gebruik je het: Patiënten met zwelling of pijn in de knieholte.

Techniek: [Rechts/Links] MRI van de knie.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de fossa poplitea, uitgaand tussen de pezen van de mediale m. gastrocnemius en de m. semimembranosus [.. mm] vochtcollectie. Omgevend oedeem passend bij ruptuur [afwezig/aanwezig].

Conclusie: Popliteale (Baker-)cyste; tekenen van ruptuur [afwezig/aanwezig].

090 MRI bekken · Eenvoudige adnexcyste

Wanneer gebruik je het: Karakterisering van een cysteuze adnexlaesie die op echo is gevonden.

Techniek: MRI bekken met contrast; T1, vetonderdrukte T1, T2, DWI.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] in het ovarium [.. mm] grote, dun- en gladwandige cysteuze laesie, homogeen hyperintens op T2, zonder solide component of aankleurende septa.

Conclusie: [Rechts/Links] laesie in het ovarium passend bij een eenvoudige cyste. De noodzaak van follow-up moet door het klinische team worden bepaald op basis van de leeftijd en de menopauzale status van de patiënte.

DEEL 4

Echo en Doppler

30 sjablonen: 5 normaal, 25 veelvoorkomende bevindingen tijdens dienst en in de routine (inclusief POCUS en eFAST).

091 Echo totale abdomen · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Echo's van het abdomen zonder pathologie bij buikpijn of routinecontrole.

Techniek: Echo totale abdomen; [nuchter].

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Lever van normale grootte en echogeniciteit, geen focale laesie gezien. Galblaas met normale wand, anechogeen lumen; geen stenen gezien. Intra- en extrahepatische galwegen niet gedilateerd. Pancreas [zichtbare delen] normaal. Milt van normale grootte. Beide nieren van normale grootte en parenchymechogeniciteit; pyelocaliceaal systeem niet gedilateerd. Blaas [gevuld, normale wand]. Geen vrij vocht in het abdomen.

Conclusie: Op de echo van de totale abdomen geen pathologie vastgesteld.

092 Echografie urinewegen · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Casussen met flankpijn, urineweginfectie of nierfunctiestoornis waarbij je geen pathologie ziet.

Techniek: Echografie van de urinewegen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Beide nieren van normale grootte, ligging en parenchymdikte; corticomedullaire differentiatie behouden. Pyelocalicieel systeem niet gedilateerd. Geen steen of massa gezien. Blaas [gevuld, normale wand, anechogeen lumen].

Conclusie: Geen pathologie vastgesteld op de echografie van de urinewegen.

093 Echo schildklier · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Casussen met de vraag naar schildklierdisfunctie of een palpabele zwelling waarbij je geen pathologie ziet.

Techniek: Echo schildklier en hals; hoogfrequente lineaire probe.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Schildklier van normale grootte met homogene echogeniciteit van het parenchym. Geen nodi. Normale vascularisatie op kleurendoppler. Geen pathologisch ogende lymfeklieren in de hals.

Conclusie: Op de echo van de schildklier geen pathologie vastgesteld.

094 Veneuze doppler onderste extremiteit · Normaal

NORMAAL

Wanneer gebruik je het: Veneuze doppleronderzoeken zonder trombose bij verdenking op DVT.

Techniek: [Rechts/Links] veneuze Doppler-echo van de onderste extremiteit; grijswaardencompressie, kleuren- en spectrale Doppler.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Vena femoralis communis, vena femoralis en vena poplitea volledig comprimeerbaar; geen trombus in het lumen. Volledige lumenvulling op kleurendoppler, ademhalingsvariatie en augmentatierespons aanwezig bij spectraal onderzoek. [Kuitvenen zijn wel/niet beoordeeld].

Conclusie: [Rechts/Links] onderste extremiteit [in de diepe venen] geen trombose vastgesteld.

095 eFAST · Negatief

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij een traumapatiënt bij bedside eFAST geen vrij vocht en geen pneumothorax ziet.

Techniek: Bedside eFAST.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen vrij vocht in de ruimte van Morison, de splenorenale regio of het kleine bekken. Subxifoïdaal geen pericardeffusie. Bilateraal lung sliding aanwezig.

Conclusie: Bij eFAST geen aanwijzingen voor vrij vocht, pericardeffusie of pneumothorax. Een negatieve eFAST sluit orgaanletsel niet uit; afhankelijk van de klinische toestand wordt CT aanbevolen.

096 Echo abdomen · Cholelithiasis

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je in de galblaas een echogene focus met slagschaduw ziet.

Techniek: Echo abdomen; nuchter.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In het lumen van de galblaas, de grootste [.. mm] grote echogene foci met posterieure slagschaduw, beweeglijk bij houdingsverandering. Wanddikte [normaal/verhoogd]. Pericholecystitisch vocht [afwezig/aanwezig]. Sonografisch Murphy-teken [negatief/positief]. Ductus choledochus [.. mm].

Conclusie: Cholelithiasis. Bevinding passend bij acute cholecystitis [niet gezien/wel gezien].

097 Echo abdomen · Acute cholecystitis

Wanneer gebruik je het: Casussen met pijn in het rechterbovenkwadrant, koorts en een positief sonografisch teken van Murphy.

Techniek: Echo abdomen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Galblaas gedistendeerd, wand verdikt [en oedemateus, dubbele contour]; in het cervicale deel [.. mm] steen. Pericholecystisch vocht [aanwezig]. Sonografisch Murphy-teken positief.

Conclusie: Bevindingen passend bij acute calculeuze cholecystitis. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

098 Echografie urinewegen · Hydronefrose

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij flankpijn, nierkoliek of nierfunctiestoornis dilatatie van het pyelocaliceale systeem ziet.

Techniek: Echografie van de urinewegen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] in de nier [licht/matig/uitgesproken] pyelocaliceale dilatatie; proximale ureter [gedilateerd/niet zichtbaar]. Parenchymdikte [behouden/verdund]. Als oorzaak van de obstructie [steen van .. mm op de ureterovesicale overgang/geen duidelijke oorzaak gezien]. Blaas [..].

Conclusie: [Rechts/Links] [licht/matig/uitgesproken] hydronefrose; [mogelijke oorzaak]. Als de oorzaak onduidelijk is, wordt correlatie met blanco CT aanbevolen.

099 FAST · Vrij vocht in de ruimte van Morison

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij een traumapatiënt vrij vocht ziet bij FAST. Spoedmelding.

Techniek: Bedside FAST.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de ruimte van Morison [en in de splenorenale regio/het bekken] anechogeen vrij vocht. Pericardeffusie [afwezig/aanwezig].

Conclusie: FAST positief: [In de ruimte van Morison] vrij vocht. Afhankelijk van de hemodynamische toestand spoedeisende klinische beoordeling; aan het klinische team [uur] gemeld.

100 Echo thorax · Pleuravocht

Wanneer gebruik je het: Verdenking op effusie op de röntgenfoto of bepaling van hoeveelheid en locatie vóór thoracocentese.

Techniek: Echo thorax; [in zittende positie], intercostale scan.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links/Bilateraal] in de pleuraholte [anechogeen/met echogene inhoud/met septa] vocht; op het diepste punt [.. mm]. Compressieatelectase van de aangrenzende long. [Geen pleurale nodulariteit.]

Conclusie: [Rechts/Links] [anechogeen/gecompliceerd van aspect] pleuravocht.
[Geschikt venster voor thoracocentese gemarkeerd.]

101 Longecho · B-lijnen

Wanneer gebruik je het: Casussen met B-lijnen op bedside longecho bij een patiënt met dyspneu.

Techniek: Bedside echo van de longen; bilaterale zonescan.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Bilateraal [anterieur en lateraal] in de regio's, in elk gebied meerdere B-lijnen. Pleuralijn [glad/onregelmatig en verdikt]. Pleuravocht [afwezig/aanwezig].

Conclusie: Bilaterale diffuse B-lijnen; passend bij een interstitieel syndroom. In combinatie met een gladde pleuralijn mogelijk passend bij cardiogeen longoedeem; klinische en echocardiografische correlatie aanbevolen.

102 Veneuze Doppler · Diepe veneuze trombose

Wanneer gebruik je het: Casussen met een niet-comprimeerbare vene bij een patiënt met zwelling en pijn van het been. Melden.

Techniek: [Rechts/Links] veneuze Doppler-echo van de onderste extremiteit.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Vena femoralis communis/femoralis/poplitea] in de vene, niet comprimeerbaar, het lumen [gedeeltelijk/volledig] vullende echogene trombus; op kleurendoppler [geen flow/partiële flow]. Trombus [proximale grens: ..].

Conclusie: [Rechts/Links] [femoropopliteaal] segment bevindingen passend bij acute diepe veneuze trombose. Aan het klinische team [uur] gemeld.

103 Echo rechteronderkwadrant · Acute appendicitis

Wanneer gebruik je het: Casussen waarin je bij een kind, een jonge of een zwangere patiënt met pijn in het rechteronderkwadrant een ontstoken appendix ziet.

Techniek: Echo rechteronderkwadrant; techniek met graduele compressie.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In het rechteronderkwadrant, niet comprimeerbaar, [.. mm] blind eindigende tubulaire structuur met een diameter van (appendix); verhoogde vascularisatie in de wand op kleurendoppler. Toegenomen echogeniciteit van het omliggende vet. Appendicoliet [aanwezig/afwezig]. Periappendiculair vocht [afwezig/aanwezig].

Conclusie: Bevindingen passend bij acute appendicitis. Aan het klinisch team [uur] gemeld. / Appendix niet in beeld gebracht; dit sluit appendicitis niet uit.

104 Echo aorta abdominalis · Aneurysma

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij screening, een pulserende massa of buik-rugpijn verwijding van de aorta ziet.

Techniek: Echo aorta abdominalis; transversale en longitudinale metingen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de infrarenale abdominale aorta maximaal [.. mm] aneurysmatische verwijding met een diameter van; in het lumen [muurtrombus]. Periaortaal vocht [niet gezien/wel gezien].

Conclusie: Infrarenaal abdominaal aorta-aneurysma, maximale diameter [.. mm]. Bij een symptomatische patiënt kan ruptuur met echo niet worden uitgesloten; aan het klinisch team [uur] gemeld en CT-angiografie aanbevolen.

105 Echo schildklier · Schildkliernodus

Wanneer gebruik je het: Palpabele nodus of incidentele schildkliernodus.

Techniek: Echo schildklier; lineaire probe, kleurendoppler.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Schildklier [rechts/links] kwab [boven/midden/onder] in het deel [.. x .. x .. mm] groot, [solide/cysteus/gemengd], [hypo-echogeen/iso-echogeen/hyperechogeen], [glad/onregelmatig] begrensde nodule. Microcalcificaties [afwezig/aanwezig]. [Verticale oriëntatie van de lange as afwezig/aanwezig]. Pathologische lymfeklieren in de hals [afwezig/aanwezig].

Conclusie: Schildklier [rechter kwab]: [.. mm] nodule; volgens de risicoclassificatie die je instelling gebruikt [categorie]. De noodzaak van fijnenaaldaspiratiebiopsie en follow-up moet volgens deze classificatie worden bepaald.

106 Echo abdomen · Leversteatose

Wanneer gebruik je het: Casussen met een diffuus verhoogde echogeniciteit van het leverparenchym.

Techniek: Echo abdomen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Lever [normaal van grootte/vergroot]; echogeniciteit van het parenchym diffuus verhoogd ten opzichte van de nierschors; wanden van de vena portae en diafragma [te onderscheiden/niet te onderscheiden]. Geen focale laesie gezien.

Conclusie: [Licht/Matig/Uitgesproken] beeld passend bij leversteatose.

107 Echo bekken · Verdenking extra-uteriene graviditeit

Wanneer gebruik je het: Casussen zonder intra-uteriene zwangerschap bij een patiënte met een positieve zwangerschapstest. Melden.

Techniek: Transabdominaal [en transvaginaal] echografie van het bekken.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Geen vruchtzak in de uterusholte. [Rechts/Links] in de adnexregio, los van het ovarium [.. mm] heterogene massa [/met daarin een dooierzak of embryo]. In het cavum Douglasi [met echogene inhoud] vrij vocht [aanwezig/afwezig].

Conclusie: Geen intra-uteriene graviditeit; [rechts/links] adnexmassa en [vrij vocht] samen met aanwijzingen voor een extra-uteriene zwangerschap. Aan het klinische team [uur] gemeld.

108 Echocardiografisch venster / POCUS · Pericardeffusie

Wanneer gebruik je het: Casussen met pericardvocht op subxifoïdale beeldvorming bij dyspneu, hypotensie of trauma.

Techniek: Bedside subxifoïdaal [en parasternaal] beeldvorming.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In de pericardruimte [circulair/gelokaliseerd] anechogeen vocht; op de breedste plaats [.. mm]. Diastolische collaps van het rechteratrium/de rechterventrikel [niet gezien/wel gezien].

Conclusie: [Weinig/Matig/Veel] pericardeffusie. Aanwijzingen voor tamponnade [afwezig/aanwezig; gemeld als spoedbevinding]. Echocardiografie aanbevolen voor gedetailleerde beoordeling.

109 Echografie urinewegen · Eenvoudige niercyste

Wanneer gebruik je het: Incidentele, anechogene nierlaesies.

Techniek: Echografie van de urinewegen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] nier [boven/midden/onder] in de pool [.. mm] grote, dunwandige, anechogene cyste met posterieure akoestische versterking, zonder septa of solide component.

Conclusie: [Rechts/Links] laesie in de nier passend bij een eenvoudige corticale cyste.

110 Echo abdomen · Leverabces

Wanneer gebruik je het: Casussen met een gecompliceerde cysteuze leverlaesie bij koorts en pijn in het rechter bovenkwadrant.

Techniek: Echo abdomen; kleurendoppler.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Leversegment [..]: [.. mm] groot, met onregelmatige wand, interne echo's en [debris] hypo-echogene/complexe cysteuze laesie; daaromheen [hyperemie].

Conclusie: Leversegment [..]: laesie, mogelijk passend bij een abces. Klinische en laboratoriumcorrelatie; zo nodig CT met contrast aanbevolen. Aan het klinisch team [uur] gemeld.

111 Doppler-echo scrotum · Verdenking testistorsie

Wanneer gebruik je het: Casussen met verminderde flow in de aangedane testis bij acuut ontstane scrotale pijn. Spoedmelding.

Techniek: Grijswaarden- en kleuren-/spectrale Doppler-echo van het scrotum; vergeleken met de contralaterale testis.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] testis [vergroot, heterogeen]; intratesticulaire flow op kleurendoppler [niet gezien/duidelijk verminderd ten opzichte van de contralaterale zijde]. In de zaadstreng [whirlpoolteken]. Contralaterale testis normaal.

Conclusie: [Rechts/Links] bevindingen passend bij testistorsie. Spoedbevinding; aan het klinische team [uur] gemeld. Aanwezigheid van flow sluit torsie niet volledig uit.

112 Echo abdomen · Ascites

Wanneer gebruik je het: Beoordeling van vocht bij een opgezette buik of vóór paracentese.

Techniek: Echo abdomen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: In het abdomen perihepatisch, perisplenisch en in het kleine bekken [weinig/matig/veel] hoeveelheid [anechogeen/met echogene inhoud/met septa] vrij vocht. Levercontour [glad/nodulair].

Conclusie: [Weinig/Matig/Veel] hoeveelheid ascites. [Geschikt venster voor paracentese gemarkeerd.]

113 Echo mamma · Eenvoudige cyste

Wanneer gebruik je het: Echografische beoordeling van een palpabele massa of een op mammografie gevonden laesie.

Techniek: Echo van beide mammae; lineaire probe.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] in de borst op [..] ter hoogte van, vanaf de tepel [.. cm] afstand, [.. mm] grote, ovale, scherp begrensde, anechogene laesie met posterieure akoestische versterking.

Conclusie: [Rechts/Links] laesie in de borst passend bij een eenvoudige cyste; volgens de classificatie die je instelling gebruikt [categorie].

114 Doppler-echo carotiden · Atherosclerotische plaque

Wanneer gebruik je het: Beoordeling van de carotiden bij een beroerte, TIA of screening op vasculair risico.

Techniek: Doppler-echo van beide arteriae carotides en vertebrales.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] [a. carotis communis/bulbus/a. carotis interna] in de arterie [verkalkt/hypo-echogeen/heterogeen] atherosclerotische plaque. Piek-systolische snelheid ter hoogte van de plaque [.. cm/s]. Flow in de arteriae vertebrales [antegraad].

Conclusie: [Rechts/Links] [a. carotis interna] atherosclerotische plaque in de arterie; stenosegraad volgens de Doppler-criteria die in jouw ziekenhuis worden gebruikt [graad]. Bij een significante stenose correlatie met CT- of MR-angiografie aanbevolen.

115 Echo abdomen · Verwijding van de ductus choledochus

Wanneer gebruik je het: Casussen met verwijde galwegen bij verhoogde cholestaseparameters of icterus.

Techniek: Echo abdomen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: Ductus choledochus [.. mm] gedilateerd tot een diameter van; intrahepatische galwegen [gedilateerd/niet gedilateerd]. In de distale ductus choledochus [.. mm steen/oorzaak van de obstructie niet te onderscheiden; distaal deel door darmgas niet in beeld]. In de galblaas [steen aanwezig/afwezig].

Conclusie: Verwijding van de ductus choledochus; [mogelijke oorzaak]. Als de oorzaak niet is vastgesteld, wordt MRCP aanbevolen.

116 Echografie urinewegen · Niersteen

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij flankpijn of hematurie in de nier een focus met slagschaduw ziet.

Techniek: Echografie van de urinewegen.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] nier [onder/midden/boven] in de kelk van de pool [.. mm] grote echogene focus met slagschaduw (twinkling-artefact op kleurendoppler [aanwezig]). Pyelocalicieel systeem [niet gedilateerd/gedilateerd].

Conclusie: [Rechts/Links] in de nier [.. mm] steen; [geen hydronefrose/met begeleidende hydronefrose].

117 Long-POCUS · Tekenen van pneumothorax

Wanneer gebruik je het: Casussen na trauma of een ingreep waarbij op bedside echo van de longen geen lung sliding te zien is. Spoedmelding.

Techniek: Bedside echo van de longen; voorste thoraxwand, M-mode.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] op de voorste thoraxwand geen lung sliding gezien; geen B-lijnen. In M-mode [barcode-/stratosfeerteken]. Longpunt (lung point) [gezien/niet gezien].

Conclusie: [Rechts/Links] aanwijzingen voor pneumothorax ([lung point gezien]). Aan het klinisch team [uur] gemeld.

118 Echo abdomen (kind) · Invaginatie

Wanneer gebruik je het: Casussen met een target sign bij jonge kinderen met intermitterende buikpijn en braken. Spoedmelding.

Techniek: Echo abdomen; lineaire en convexe probe.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechterbovenkwadrant/Rechter abdomen]:, met in transversale doorsnede een target-aspect en in longitudinale doorsnede een pseudonier-aspect [.. mm] darmsegment met een diameter van. Daarin [lymfeklier/lead point] [afwezig/aanwezig]. Wandflow op kleurendoppler [behouden/verminderd]. Vrij vocht in de omgeving [afwezig/aanwezig].

Conclusie: [Ileocolisch] bevindingen passend bij invaginatie. Spoedbevinding; aan het klinische team [uur] gemeld.

119 Doppler-echo scrotum · Epididymo-orchitis

Wanneer gebruik je het: Casussen waarbij je bij scrotale pijn en zwelling hyperemie van de epididymis ziet.

Techniek: Grijswaarden- en kleurendoppler-echo van het scrotum.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Rechts/Links] epididymis [kop/corpus] deel vergroot en heterogeen; op kleurendoppler duidelijk verhoogde vascularisatie. In de testis [hyperemie aanwezig/afwezig]. Reactieve hydrokèle [aanwezig/afwezig]. Contralaterale testis en epididymis normaal.

Conclusie: [Rechts/Links] [epididymitis/epididymo-orchitis] passende bevindingen. De testiculaire doorbloeding is behouden.

120 Echo weke delen · Abces

Wanneer gebruik je het: Zoeken naar een collectie bij casussen met subcutane zwelling, roodheid en pijn.

Techniek: Echo oppervlakkige weke delen; lineaire probe, kleurendoppler.

Vergelijking: [datum] vergeleken met het eerdere onderzoek van [datum]. / Er is geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.

Bevindingen: [Regio]: in het subcutane vetweefsel [.. mm] grote, onregelmatig begrensde hypo-echogene collectie met interne echo's en inhoud die bij compressie beweegt; daaromheen verhoogde vascularisatie en oedeem (cobblestone-aspect).

Conclusie: [Regio]: collectie passend bij een weke-delenabces en tekenen van omgevende cellulitis.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu Bonus 1 · Bank met 200 conclusiezinnen. Het moeilijkste deel van het sjabloon is het veld Conclusie; sluit elk verslag af met één heldere zin, met de conclusiezinnen voor normale, incidentele en spoedbevindingen uit de bank.

Vóór het ondertekenen **Snelle bonus · Checklist voor het verslag op één pagina** altijd bij de hand houden.